



把控健康

健康管理学习手册
(2024)



把控人生，从把控健康开始。

手册说明

本手册主要面向人到中年后，健康管理意识觉醒，想系统、科学地管理自己的健康并且关注父母健康的中年人。

本手册内容来自于三个方面：一、我对**健康管理知识的梳理和总结**，除了近5-10年最好的健康管理书籍《超越百岁》的内容，我也会结合国内关于健康管理的知识，包括几大慢性病的临床指南和专家共识，以及《中国居民膳食指南》。二、我**个人的健康管理经验**，包括日常跑步、力量训练、参加马拉松比赛，日常饮食，以及如何成功戒烟、如何控酒的经验 and 看法。三、我带父母在北京三甲医院看病（慢性病）的经验分享，以及**父母的健康管理方法**。

本手册的将按照以下逻辑展开：首先，我们需要明确健康管理的目标是什么？因为目标越明确，越会取的成效。其次，我们要理解衰老和慢性病的原理，没有对衰老和慢性病的理解，就不知道我们的敌人是什么。。第三，我会给出健康管理的方法和工具。最后，我会分享我个人的健康管理方案，以及我给父母制定的健康管理方案。

除了上面的内容，我还会有延伸内容分享。

重要声明：

本手册旨在科普先进的、全面的、科学的健康管理知识和理念，不做任何医疗方面的建议，如有不适建议就医。

手册目录

1. 前言：手册的来龙去脉
2. 目标：健康管理的目标
3. 原理：理解衰老和慢性病
 - 3.1 理解衰老
 - 3.2 四大慢性病
4. 工具：健康管理的四大方面
 - 4.1 运动
 - 4.2 营养和饮食
 - 4.3 睡眠
 - 4.4 情绪健康
5. 案例
 - 5.1 我的健康管理之路
 - 5.2 我是如何成功戒烟的
 - 5.3 如何0-1跑完马拉松比赛
 - 5.4 给父母的健康管理方案
6. 附录

1. 前言

我为什么要写这个手册？这里快速交代一下原因。

我有保持读书的习惯，差不多每年读三四十本，我也一直想找一本在健康管理方面，科学、系统的书，但很遗憾，一直没能遇到。直到今年初，我遇到了 **《超越百岁》这本书，近5-10年最好的健康管理书籍**。我读了四五遍，做过思维导图，也做了四十几页的课件，录制了两个半小时的课程，并且做了近六十条短视频，还在持续做直播分享。只因为这本书兼具科学性、系统性、实践性，我从中受益很多，我也希望我的亲人、朋友从中受益。

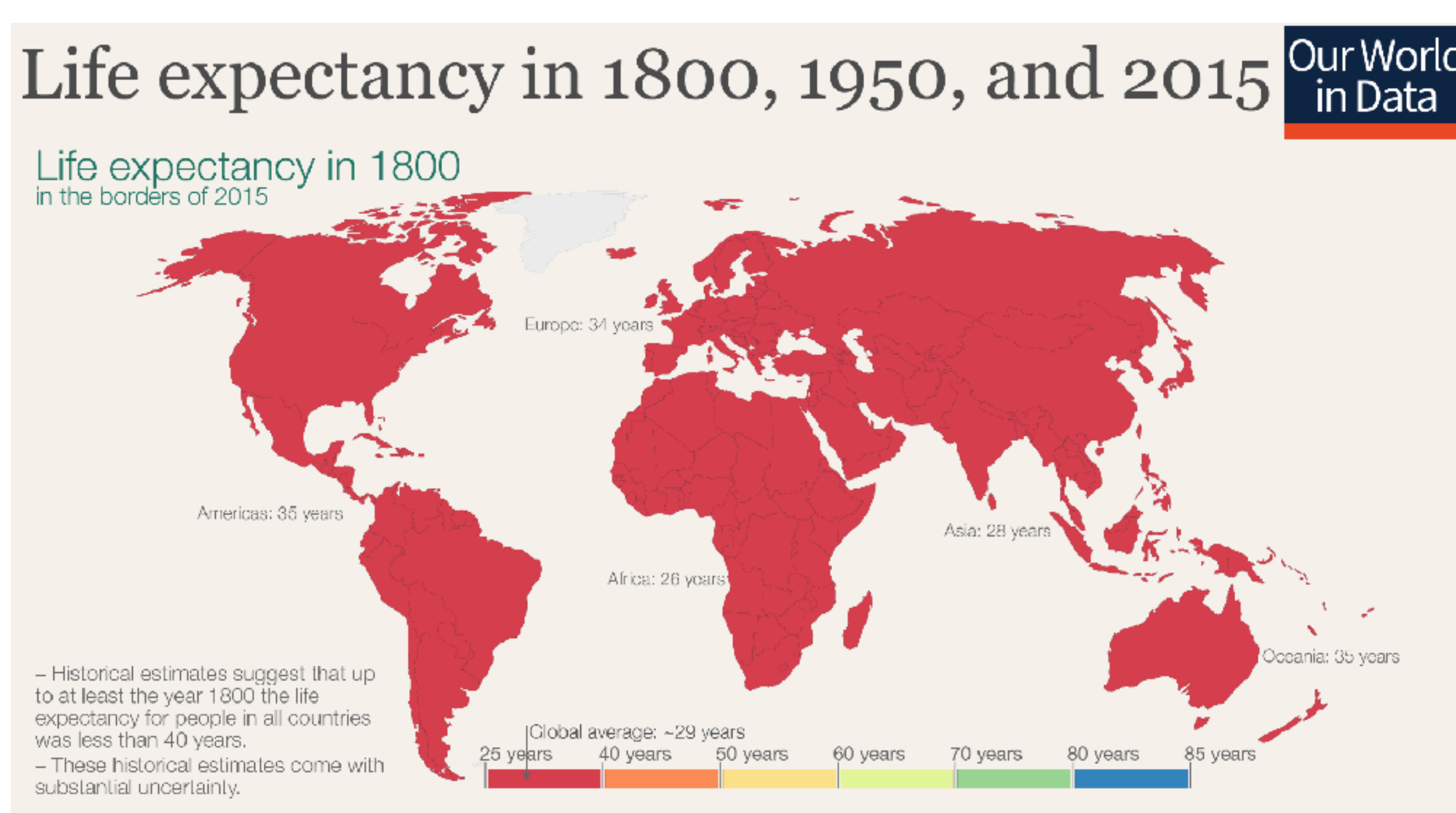
第二个原因是，我在做了以上推广后，有朋友说我是《超越百岁》推广第一人，我想索性坚持做到底，把本书的干货梳理成一个手册，造福更多的人。

第三个原因是，现在经济不景气，而且中国的老龄化社会已经全面到来，养老问题、老年人健康问题、照护问题等，都很紧迫。因此，我认为梳理出这样一个健康管理的手册，也会有很大的社会价值。

为什么是基于《超越百岁》这本书呢？因为这本书是目前最科学、最系统的健康管理书籍，作者会带我们去梳理健康管理的目标、带我们理解衰老和慢性病，然后给出非常科学且低成本的健康管理工具，这些是其他健康管理书籍达不到的。

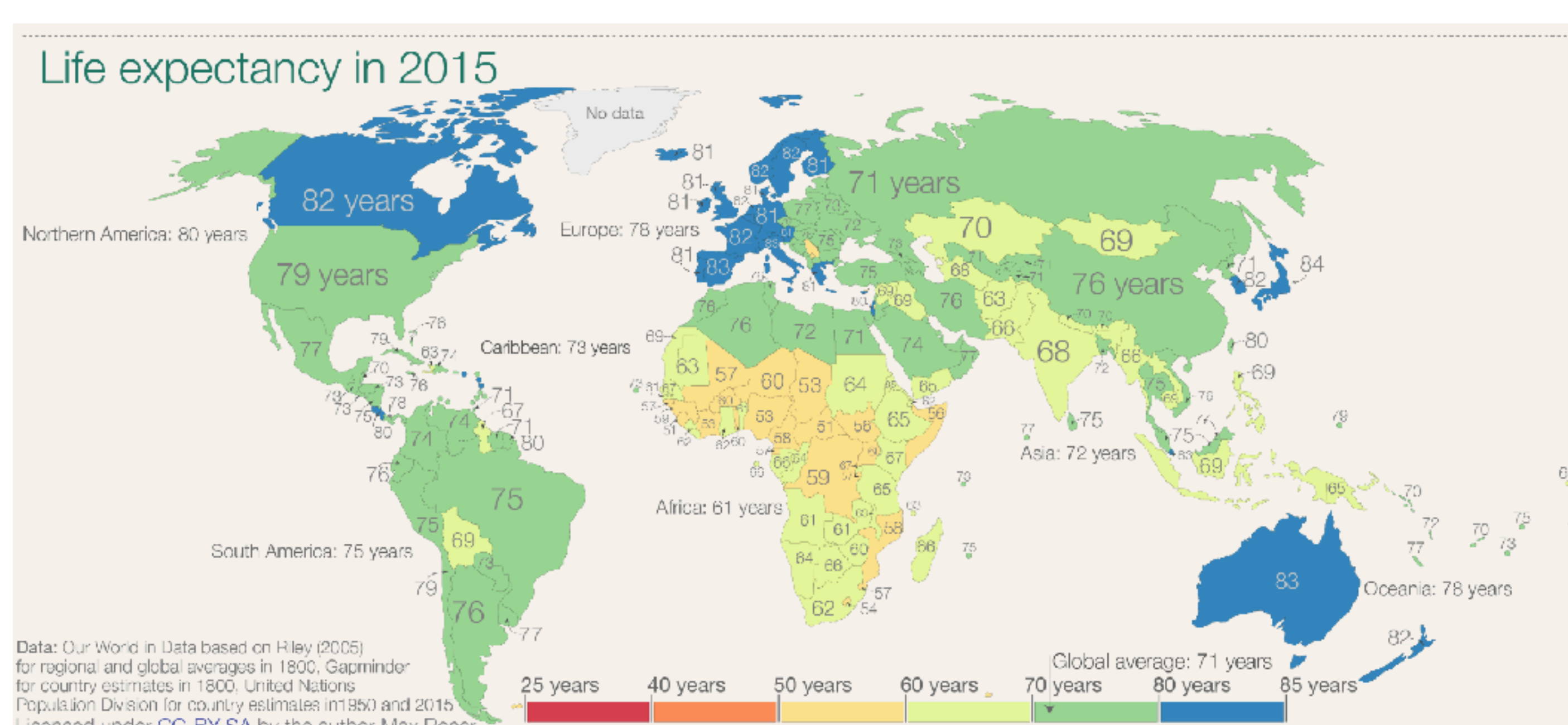
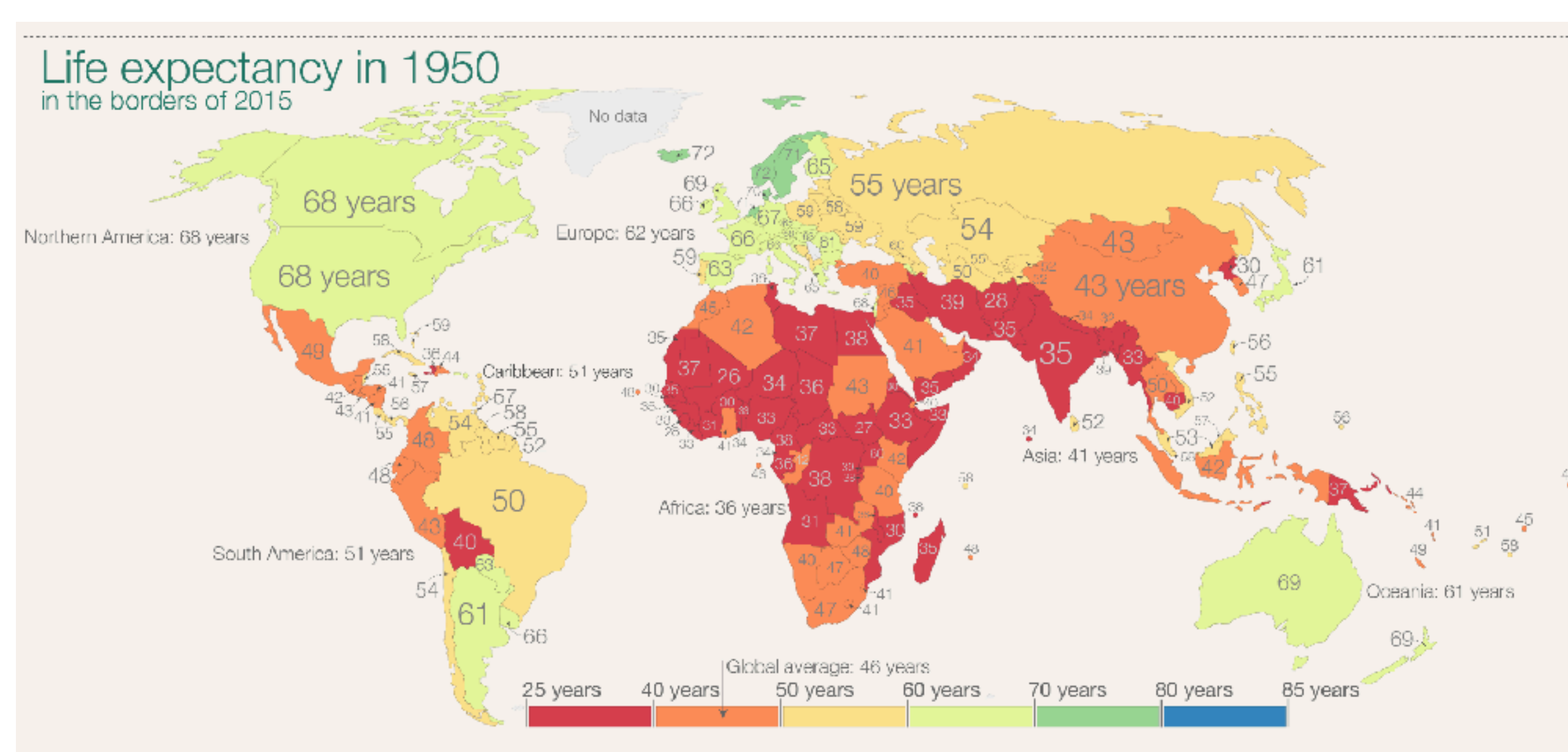
2. 目标

我们健康管理的目标是什么？看似显而易见，其实每个人都有不同的答案。有些人说不想得病，有些人说多活几年，有些人说想要身体更健康……让我们回到现实，看看我们面临的新问题，人类平均预期寿命的大副增加。



29岁 /1800年代

46岁 /1950年代



71岁 /2015年

2023年，我国居民人均预期寿命提高到 78.6岁

人均预期寿命的增加，意味着一件事——人们死亡方式发生改变。历史上，人类基本是急性死亡，以受伤、感染、事故、传染病等死因为主。而今天，人类的死亡方式则是慢性死亡。大概率会死于慢性病「四骑士」中的一种：心脏病、癌症、神经退行性疾病（指阿兹海默症、老年痴呆等神经方面退化疾病）、2型糖尿病及相关代谢障碍。



因此，我们的寿命不再单一，而是有“两个寿命”，一个是能活多久，即“实际寿命”，一个是没有疾病和残疾的寿命，即“健康寿命”，而实际寿命减去健康寿命，便是“边缘十年”，指晚年被疾病困扰、行动受限的十年。目前，中国人均预期寿命 78.6 岁，根据《世界卫生组织2018》数据，2016年中国的人均健康预期寿命为68.7岁，相减正好接近十年。

实际寿命 – 健康寿命 = 边缘十年

小结

人类的平均预期寿命延长了，接近翻倍，因此人类的死亡方式发生了变化，由过去的快速死亡变为现在的慢性死亡。同时，慢性病又会造成被疾病困扰、行动受限的「边缘十年」。

基于这个现实，我们健康管理的终极目标就是：**预防慢性疾病，减少边缘十年，延长健康寿命**。为了方便记忆，可以称之为“「十八字箴言」”。

这个目标，还有一个更通俗的版本，就是：**活得长，老得慢，病得晚，死得快**。

你可能觉得这个目标大家都知道，没什么了不起。但是，问题来了，或许很多人都知道目标是多活几年，但是，不知道该如何做，如何预防慢性疾病，如何避免老年卧床，如何减少边缘十年，更不知道如何延长健康寿命。

没错，**我们缺少一个框架！**

我在好几年前便认识到了健康管理的重要性，也零零碎碎掌握了很多健康知识，但是从不成体系，直到遇见了《超越百岁》，这本书是我读到过能讲清楚健康管理体的书，目标、为什么、怎么做，非常清晰。健康管理的系统框架见下页。

这个系统框架是最难得的，这也是我坚持分享这本书的原因。

系统框架

目标

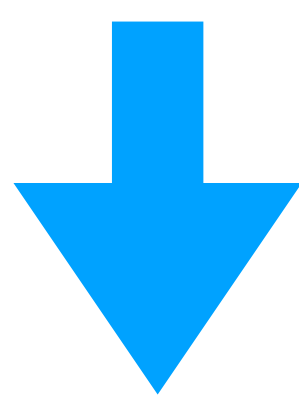
十八字箴言

预防慢性疾病

减少边缘十年

延长健康寿命

通俗版本：活得长，老得慢，病得晚，死得快



战略

理解衰老和慢性病“四骑士”

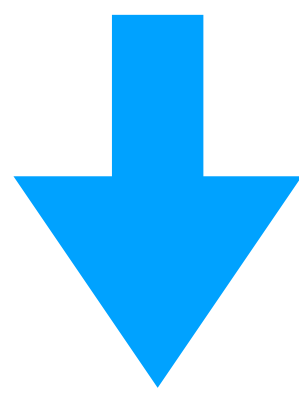
2型糖尿病

心脏病

癌症

神经退行性疾病

(一个有科学依据的认知框架)



战术

医学3.0 五大领域

运动

营养和饮食

睡眠

情绪健康

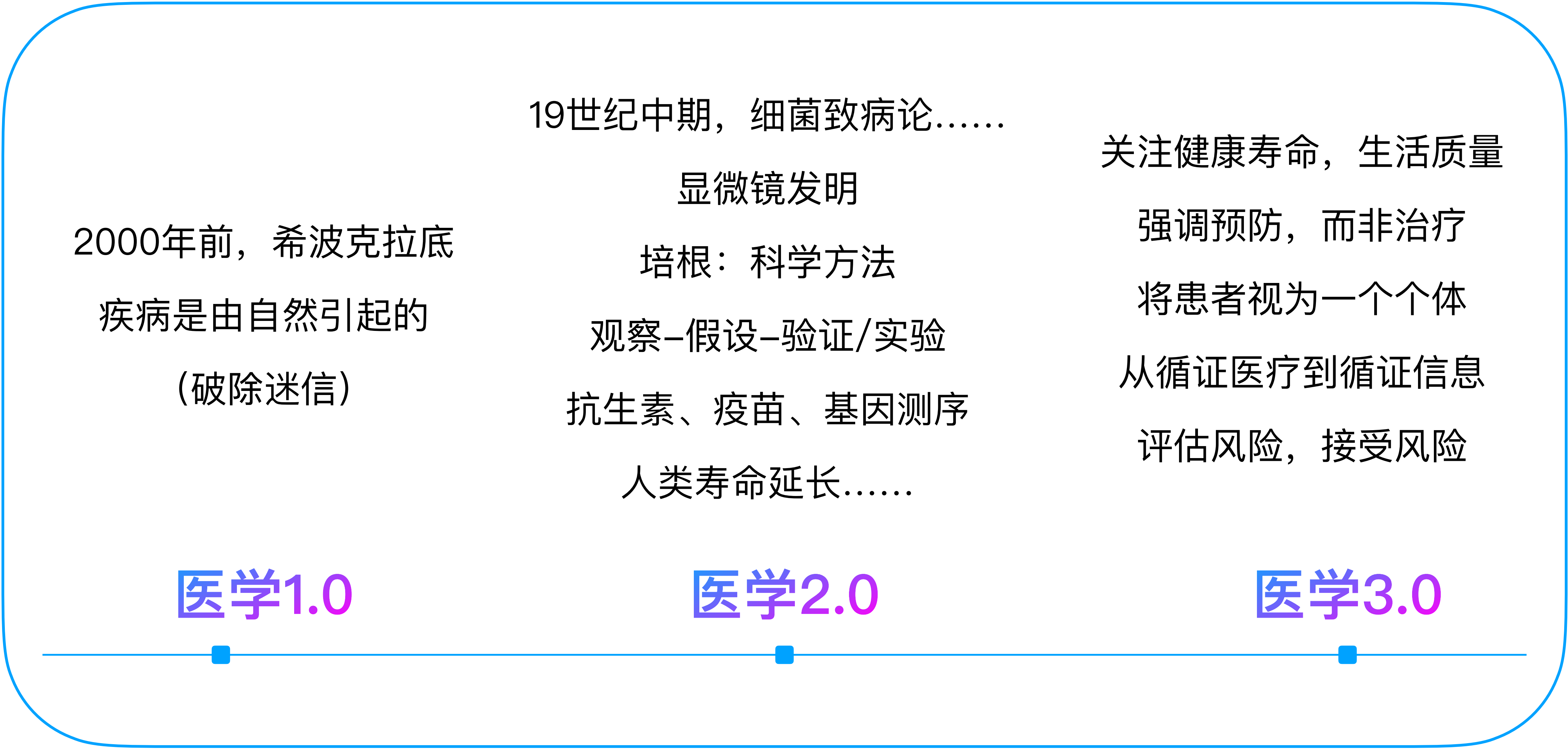
外源性分子（药物、激素、补充剂等）

如果不了解战略， 不了解其中的科学原理， 我们的战术就没有太大意义， 我们将永远在时尚饮食、时尚锻炼、神奇补充剂的旋转木马上兜圈子。

—— 彼得·阿提亚， 《超越百岁》

关键概念

医学3.0



医学2.0时代，我们都是被动的病人，发现有病了才去看病。头疼医头，脚疼医脚。

而**医学3.0**，要求我们主动管理自己的健康，以预防为主。要求“**治未病**”。需要我们有一定程度的医学知识，清楚自己的目标，积极行动，做出改变。

上工治未病，不治已病。

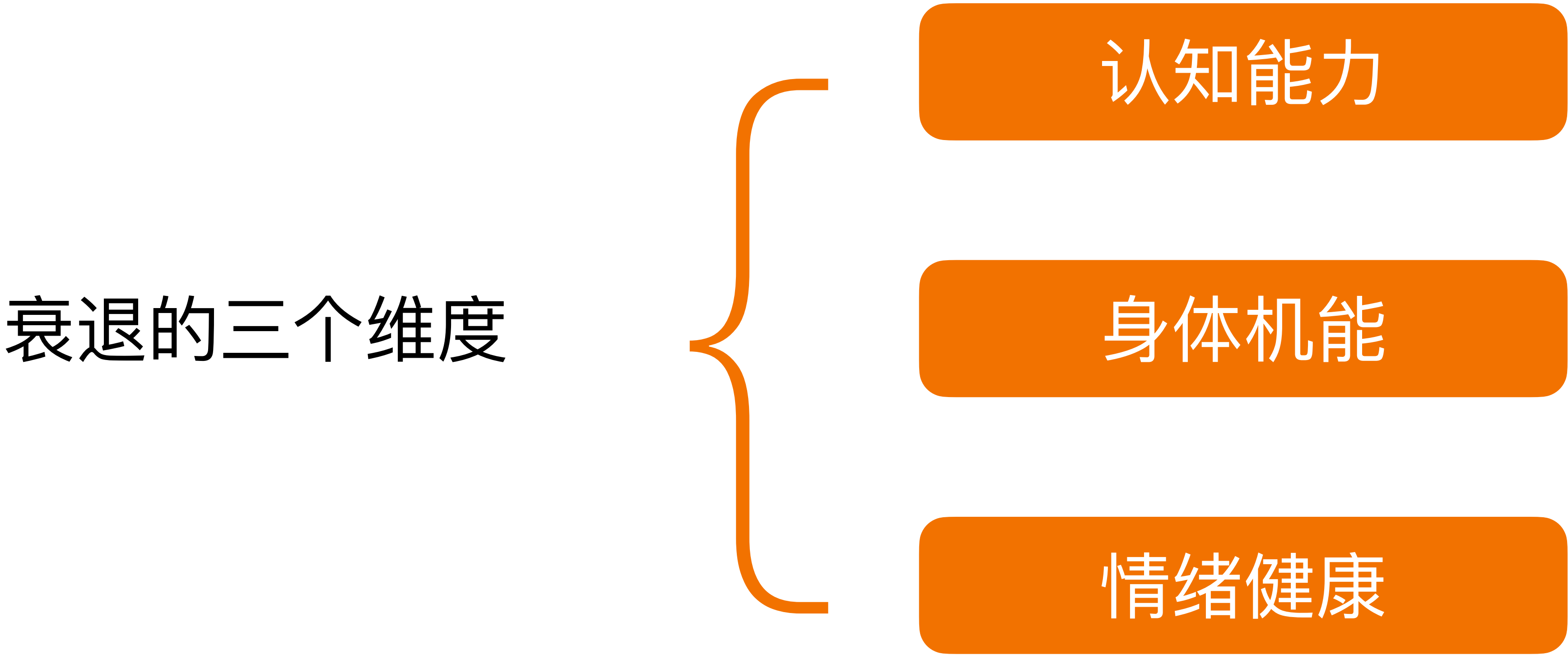
——《黄帝内经》

3. 原理：衰老和慢性病

我们想要预防慢性疾病，减少边缘十年，延长健康寿命，首先要理解衰老和慢性病的原理。衰老的特征是：

生理完整性的逐渐丧失，导致功能受损，更容易死亡。

这种退化是人类主要病症的首要风险因素，包括癌症、糖尿病、心脑血管疾病和神经退行性疾病。衰老的过程本身让我们更容易患上慢性病。



认知能力衰退，包括大脑反应能力变慢，记忆力开始衰退，执行能力变差，性格也会发生变化。

身体机能下降，包括肌肉量损失，骨密度降低，心肺有氧耐力变差，稳定性和平衡感变差（摔倒是老年人最大的危险因素。）

情绪健康对老年人来说也很重要，如果没有情绪健康，比如得不到社会关爱，没有友谊，晚年会很凄惨。

3.1 衰老

世卫组织（WHO）关于衰老的解释

衰老的定义

从生物学角度来看，衰老是各种分子和细胞损伤随时间逐步积累的结果。这会导致身心能力逐渐下降，患病以及最终死亡的风险日益增加。但是，这些变化不是线性的，也没有清晰的逻辑，且同一个人的年龄关系不大。老年状态的多样性不是偶然的，除了生理上的变化，衰老还与其它一些生命转折点，如退休、搬迁到更合适的住所以及朋友和伴侣的死亡等有关。

与衰老相关的常见健康状况

老年人的常见症状包括听力损失、白内障和屈光不正、背部和颈部疼痛及骨关节炎、慢性阻塞性肺病、糖尿病、抑郁症和痴呆症。另外，随年纪增长，人们可能同时有几种症状。

老年的另一个特点是出现若干种复杂的健康状况，这些状况通常被称为老年综合征。这些健康状况往往是多种基础因素（虚弱、小便失禁、跌倒、谵妄和褥疮等）造成的后果。

影响健康老龄化的因素

寿命延长不仅能给老年人及其家庭，而且能给整个社会带来机会。寿命增加使得人们有机会从事新的活动，如进修，从事新职业或长期以来被忽视的爱好等。然而这些机会和贡献很大程度上取决于一个因素：健康。

有证据表明，健康生活年数基本未变，这意味着在额外寿命中健康状况欠佳。如果人们能够健康地度过这些额外的晚年岁月，并且能够生活在有益环境中，则他们从事自己认为有价值活动的的能力将与年轻人几乎没有差别。但如果增加的这些岁月基本是在身心能力衰退中度过，则对老年人和社会产生不利影响。

虽然老年人健康状况的某些变化是遗传性的，但多数是因为人们所处的自然和社会环境造成的，包括家庭、邻里和社区，以及其个人特征，如性别、族裔或社会经济地位等。人们儿时或甚至胎儿阶段的生活环境与其个人特点结合在一起，会长远地影响到其今后变老的方式。

自然环境和社会环境可以直接影响健康，也可能会阻碍或激励机会、决策和健康行为，进而对健康产生影响。终生保持健康行为，特别是均衡饮食、定期进行身体活动和避免吸烟，都有助于降低非传染性疾病的风险，提高身心能力，并延缓对护理的依赖。

支持性环境使人们能够在能力损失的情况下也能从事对其重要的活动。提供安全无障碍的公共建筑和交通工具，以及易于走动的环境都是支持性环境的例子。在针对老龄化制订公共卫生对策时，不仅应考虑采取个人和环境措施改善老年状况，还应考虑采取措施加强康复、适应和社会心理成长。

衰老及延缓衰老是当今生命科学前沿研究的热点，寻找延缓衰老的方法，对改善老年人的身体技能、提高健康寿命意义重大。由于老年人很少只患有**一种衰老相关的慢性疾病，常多种疾病同时发生**，且这些疾病的发生率通常在70岁以后显著增长，这些多发病不仅阻碍了对单一疾病进行合适的治疗，同时老年患者合用多种药物的问题也日益严重，可能会导致不良反应、难以预测的药物相互作用以及依从性差等问题，促使科学家们聚焦衰老干预研究，既通过靶向基本衰老过程，**把衰老作为一个整体来延迟、预防或减轻老年疾病和病症**，而不仅是针对某种衰老相关疾病或者衰老表征的特定疗法。

——延缓衰老药物干预研究中国老年医学专家共识(2024)

延缓衰老药物干预研究中国老年医学专家共识(2024)

刘幼硕¹ 詹俊鲲² 王建业³ 李玺⁴ 陈新宇⁵ 李锐⁶ 任俊兰⁷ 樊瑾⁸ 鲁翔⁹
彭丹涛¹⁰ 毛拥军¹¹ 吴剑卿¹² 黎健³ 中华医学会老年医学分会

《中华老年医学杂志》编辑委员会

¹中南大学湘雅二医院老年医学科,长沙 410011;²中南大学衰老与老年疾病研究所,长沙 410011;³北京医院 国家老年医学中心 中国医学科学院老年医学研究院,北京 100730;⁴西安交通大学老龄健康与老年医学中心 西安交通大学附属第二医院老年病科,西安 710004;⁵浙江医院 浙江省老年医疗中心,杭州 310013;⁶陕西省人民医院老年神经科,西安 710068;⁷广州恒诺康医药科技有限公司,广州 510535;⁸北京泰康燕园康复医院,北京 102200;⁹南京医科大学附属逸夫医院老年医学科,南京 211100;¹⁰北京中日友好医院神经内科,北京 100029;¹¹青岛大学附属医院老年医学科,青岛 266000;¹²南京医科大学第一附属医院老年医学科,南京 210029

通信作者:刘幼硕, Email: liuyoushuo@csu.edu.cn; 詹俊鲲, Email: zhanjunkun@csu.edu.cn

小结

衰老是一个系统过程，是分子和细胞层面的受损，身体机能、认知能力、情绪健康的下降，以及慢性病的出现。**衰老不是单一的症状，而是一系列复杂的症状都缓慢出现，因此，“老年综合征”是认识和理解衰老的关键。**而跟衰老紧密相关、并且危及老年生命的是四大慢性病：心脏病、糖尿病、癌症、阿兹海默症。

衰老不可逆，但可以延缓。前提是，认识我们的主要敌人——四大慢性病。

声明：以下知识来自权威指南和共识，本手册只科普，不做任何医疗建议

3.2 四大慢性病

在我们了解四大慢性病之前，我们先了解一下新陈代谢。新陈代谢是我们维持生命的基础，如果新陈代谢出了问题，则牵一发而动全身，各种健康问题都会出现。我们从中年人常见的代谢障碍——“代谢综合征”切入，来理解代谢的重要性，以及四大慢性病的相关性。

代谢综合征是一组以腹型肥胖、血糖异常、血脂异常以及高血压等聚集发病，严重影响机体健康的临床综合征，是一组在代谢上相互关联的危险因素的组合，这些因素直接促进了动脉粥样硬化性心血管疾病的发生，也增加了2型糖尿病的发病风险。

随着人口老龄化和超重肥胖的情况日趋严重，代谢综合征已成为严重影响人类健康的全球性疾患，据估算我国代谢综合征人数超过4.5亿人，几乎达到了每三个人里就有一个患有代谢综合征。

代谢综合征的诊断标准，具备以下 5 项指标中的 3 项及以上者：

- (1) 腹型肥胖(即中心型肥胖):腰围男性 ≥ 90 cm，女性 ≥ 85 cm;
- (2) 高血糖：FPG ≥ 6.1 mmol/L 和(或)2 h PG ≥ 7.8 mmol/L，和(或)已确诊糖尿病并治疗者;
- (3) 高血压：血压 $\geq 130/85$ mmHg，和(或)已确诊高血压并治疗者;
- (4) 高血脂：空腹甘油三酯 TG ≥ 1.7 mmol/L;
- (5) 高密度脂蛋白胆固醇 HDL-C < 1.04 mmol/L

 如果一个人肥胖（尤其是大肚子）、并且有三高（高血压、高血糖、高血脂）那大概率是代谢综合征了。而代谢综合征与糖尿病、心脏病、癌症、神经退行性疾病，都密切相关。

(二) 2型糖尿病

根据中国 2 型糖尿病防治指南(2020 年版), 近 30 多年来, 我国糖尿病患病率显著增加。糖尿病是严重威胁我国居民健康的四大类慢性病之一, 也是多种疾病的危险因素。

○ 糖尿病定义

糖尿病是由于胰岛素分泌及（或）作用缺陷引起的以血糖升高为特征的代谢病。糖尿病的典型症状是“三多一少”（多饮、多食、多尿、体重减轻），出现糖尿病典型症状并符合以下任何一个条件的人，可以诊断为糖尿病：

- 1、一天中任一时间血糖 $\geq 11.1\text{mmol/L}$ (200mg/dl)；
- 2、空腹血糖水平 $\geq 7.0\text{mmol/L}$ (126mg/dl)；
- 3、口服葡萄糖耐量试验2小时血糖水平 $\geq 11.1\text{mmol/L}$ (200mg/dl)。

糖尿病并发症累及血管、眼、肾、足等多个器官，致残、致死率高，严重影响患者健康。

○ 糖尿病高危人群

具备以下因素之一，即为糖尿病高危人群

- 1、年龄 ≥ 40 岁
- 2、超重与肥胖
- 3、高血压
- 4、血脂异常

- 5、静坐生活方式
- 6、糖尿病家族史
- 7、妊娠糖尿病史
- 8、巨大儿（出生体重 $\geq 4\text{Kg}$ ）生育史

6.1 mmol/L $\leq$ 空腹血糖（FBG） $< 7.0\text{mmol/L}$ ，或7.8mmol/L $\leq$ 糖负荷2小时血糖（2hPG） $< 11.1\text{mmol/L}$ ，**为糖调节受损，也称糖尿病前期，属于糖尿病的极高危人群。**

○ 糖尿病危害

糖尿病患者常伴有脂肪、蛋白质代谢异常，长期高血糖可引起多种器官，尤其是眼、心、血管、肾、神经损害或器官功能不全或衰竭，导致残废或者过早死亡。**糖尿病常见并发症包括卒中、心肌梗死、视网膜病变、糖尿病肾病、糖尿病足等。**

- （一）糖尿病患者发生心脑血管疾病的危险性更高；
- （二）糖尿病患者常伴有高血压和血脂异常；
- （三）糖尿病视网膜病变是导致成年人群失明的主要原因；
- （四）糖尿病肾病是造成肾功能衰竭的常见原因之一；
- （五）糖尿病足严重者可导致截肢。

○ 糖尿病预防

调整生活方式是预防或延缓2型糖尿病发作的最佳方式。为帮助预防2型糖尿病及其并发症，人们应当：

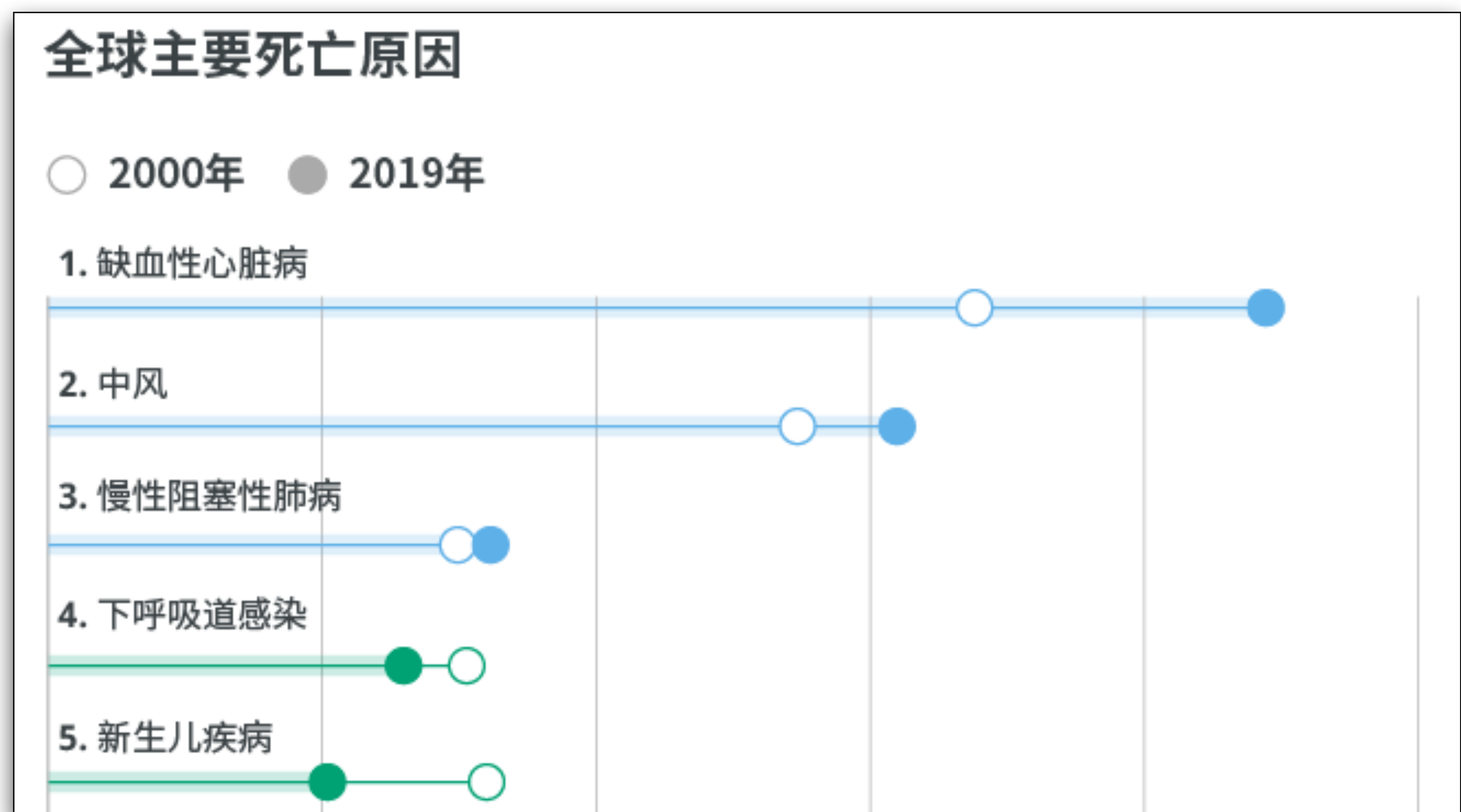
- 达到并保持健康的体重
- 保持身体活动，每天至少进行 30 分钟的中等强度运动
- 保证健康饮食，避免糖和饱和脂肪，不抽烟，控制饮酒

💡 洞察：

2型糖尿病是吃出来的“富贵病”，是我们人类古老的基因无法适应现代饮食造成的，随着我们吃的越来越多，出现了肥胖、代谢综合征、脂肪肝以及糖尿病。

糖尿病患者患心血管疾病、癌症、阿兹海默病和其它痴呆症的风险更大，可以说，糖尿病和相关的代谢功能障碍是所有这些疾病的一个共同点。

(二) 心血管疾病



根据世卫组织的报告，**心血管疾病是全球第一死亡因素。**

根据2021年国家心血管疾病中心的报告，心血管疾病也是我国城乡居民第一位死亡原因。

心血管疾病是全球范围内威胁人类生命健康的最主要的慢性非传染性疾病，是一组心脏和血管失调疾病，包括：

- 冠心病——为心肌供血的血管疾病；
- 脑血管疾病——为大脑供血的血管疾病；
- 外周动脉疾病——为四肢供血的血管疾病；
- 风湿性心脏病——由链球菌引起的风湿热对心肌和心脏瓣膜的损害；
- 先天性心脏病——先天性心脏结构畸形导致的影响心脏正常发育和功能的出生缺陷；以及
- 深静脉血栓和肺栓塞——腿部静脉中的血凝块，可能脱落并移动到心脏和肺部。

心脏病发作和中风通常是急性事件，主要是由于血管堵塞导致血液无法流向心脏或大脑。最常见的原因是向心脏或大脑供血的血管内壁发生脂肪沉积。中风可由脑血管或血凝块出血引起。

心脏病和中风**最重要的行为风险因素是不健康饮食、缺乏运动、吸烟和过量饮酒**。行为风险因素对个人的影响可能表现为血压、血糖和血脂的升高以及超重和肥胖。这些“中间风险因素”可在初级保健机构中进行测量，指示心脏病发作、中风、心力衰竭和其他并发症的风险增加。在环境风险因素中，空气污染是一个重要因素。

事实表明，**戒烟、减盐饮食、多吃水果和蔬菜、定期进行身体活动，以及避免过量饮酒可以降低罹患心血管疾病的风险**。

根据《中国血脂管理指南（2023年）》，流行病学、遗传学和临床干预研究证据充分证实，**低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)是心血管疾病的致病性危险因素**。新近研究还发现，其他含有载脂蛋白B(ApoB)的脂蛋白，包括富含甘油三酯的脂蛋白，(TRL)及其残粒，以及脂蛋白(a)[Lp(a)]，也和心血管疾病相关。

因此，**血脂检测是发现血脂异常、评估心血管疾病风险和确定干预策略的基础**。

洞察：

在代谢综合征的五项指标当中，有两项是关于血脂的。因此，如果诊断出代谢综合征，则需要提醒自己，血脂异常意味着心血管疾病的风险增大。

（三）癌症

虽然大家都“谈癌色变”，以为癌症就是绝症，其实不然，**如果能得到及早发现和有效治疗，许多癌症是可以治愈的。**因此，带着一颗平常心来看待癌症十分有必要。

癌症是一组可影响身体任何部位的多种疾病的通称，也称为恶性肿瘤。癌症的一个决定性特征是异常细胞快速生成，这些细胞超越其通常边界生长并可侵袭身体的临近部位和扩散到其它器官。后者被称为转移。**广泛转移是癌症死亡的主要原因。**

○ 癌症由何引起？

癌症源于正常细胞转变为肿瘤细胞的多阶段过程，通常从癌前病变发展到恶性肿瘤。**癌变是一个人的遗传因素与三种外部因素相互作用的结果**，外部因素包括：

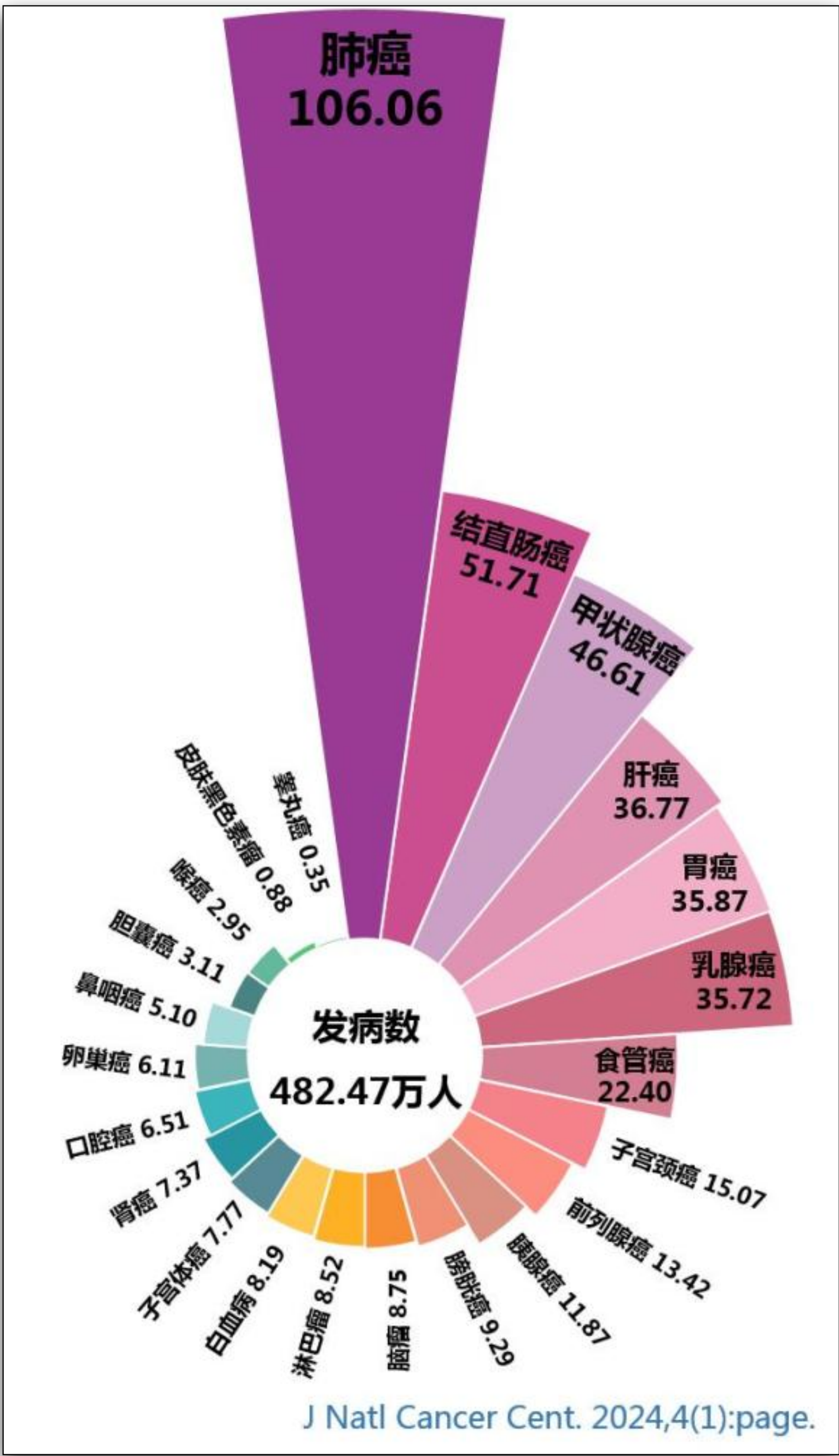
- 物理致癌物，例如紫外线和电离辐射；
- 化学致癌物，例如石棉、烟草烟雾成分、酒精、黄曲霉毒素（一种食品污染物）和砷（一种饮水污染物）；
- 生物致癌物，例如由某些病毒、细菌或寄生虫引起的感染。

根据世卫组织数据，**大约三分之一的癌症死亡源自烟草使用、高体重指数、酒精消费、水果和蔬菜摄入量低以及缺乏身体活动。**

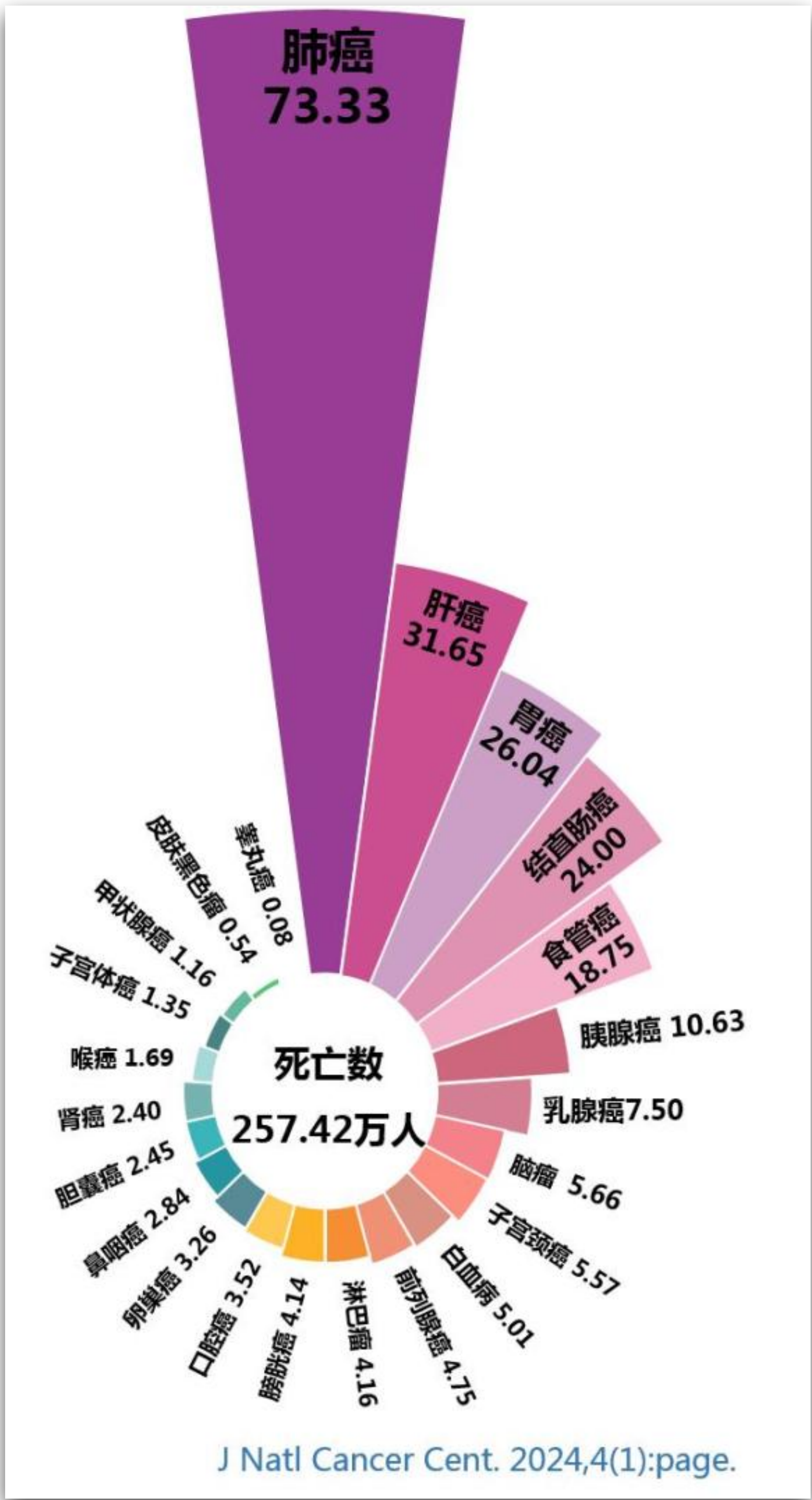
癌症发病率随着年龄的增长而急剧上升，这很可能是因为特定癌症的风险随着年龄的增长而增加。随着年龄的增长，整体风险不断积累，而同时细胞修复机制的有效性则呈下降趋势。

○ 中国癌症报告

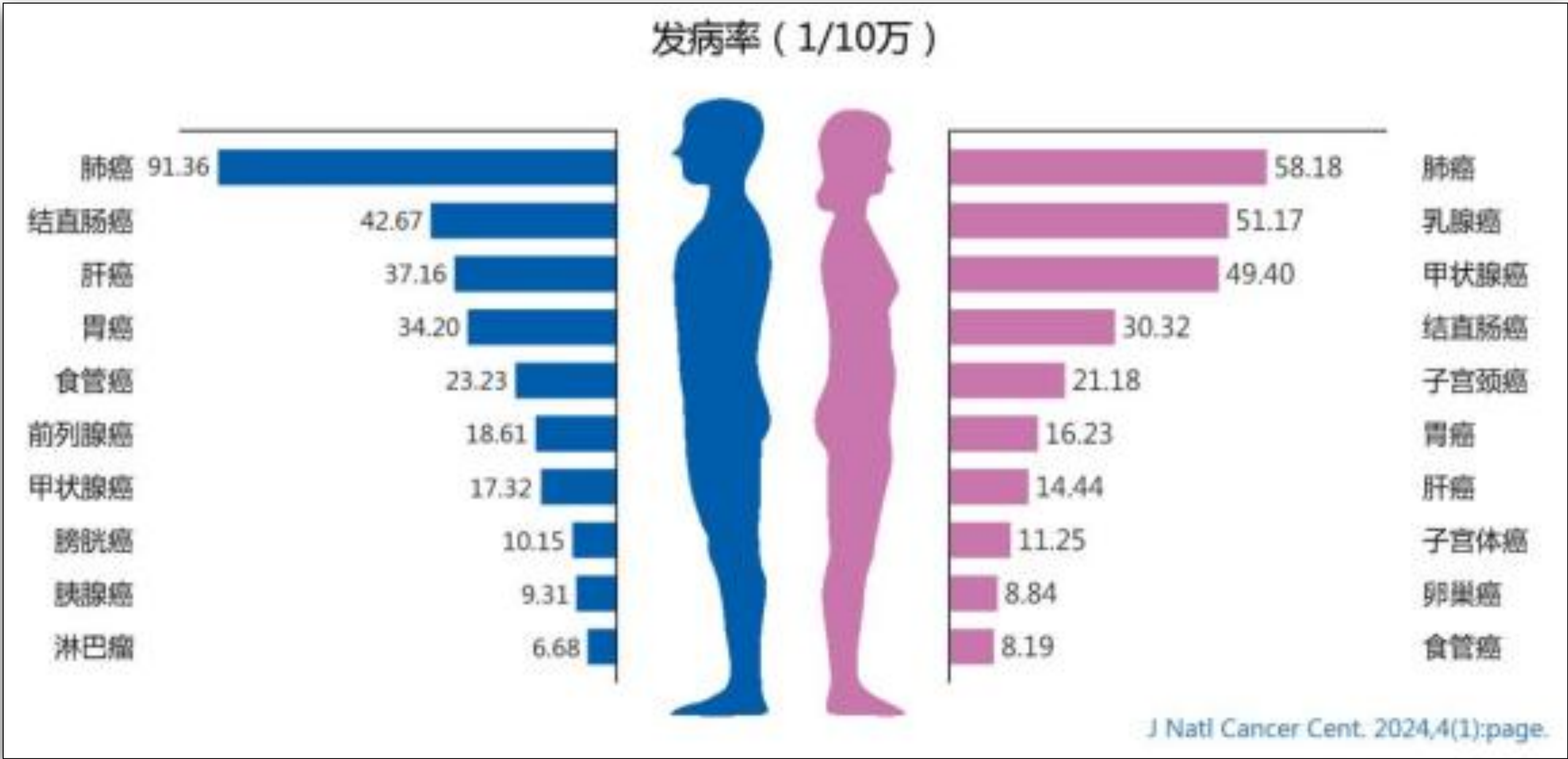
根据国家癌症中心2024年发布的全国癌症报告，以下为2022年癌症统计数据。



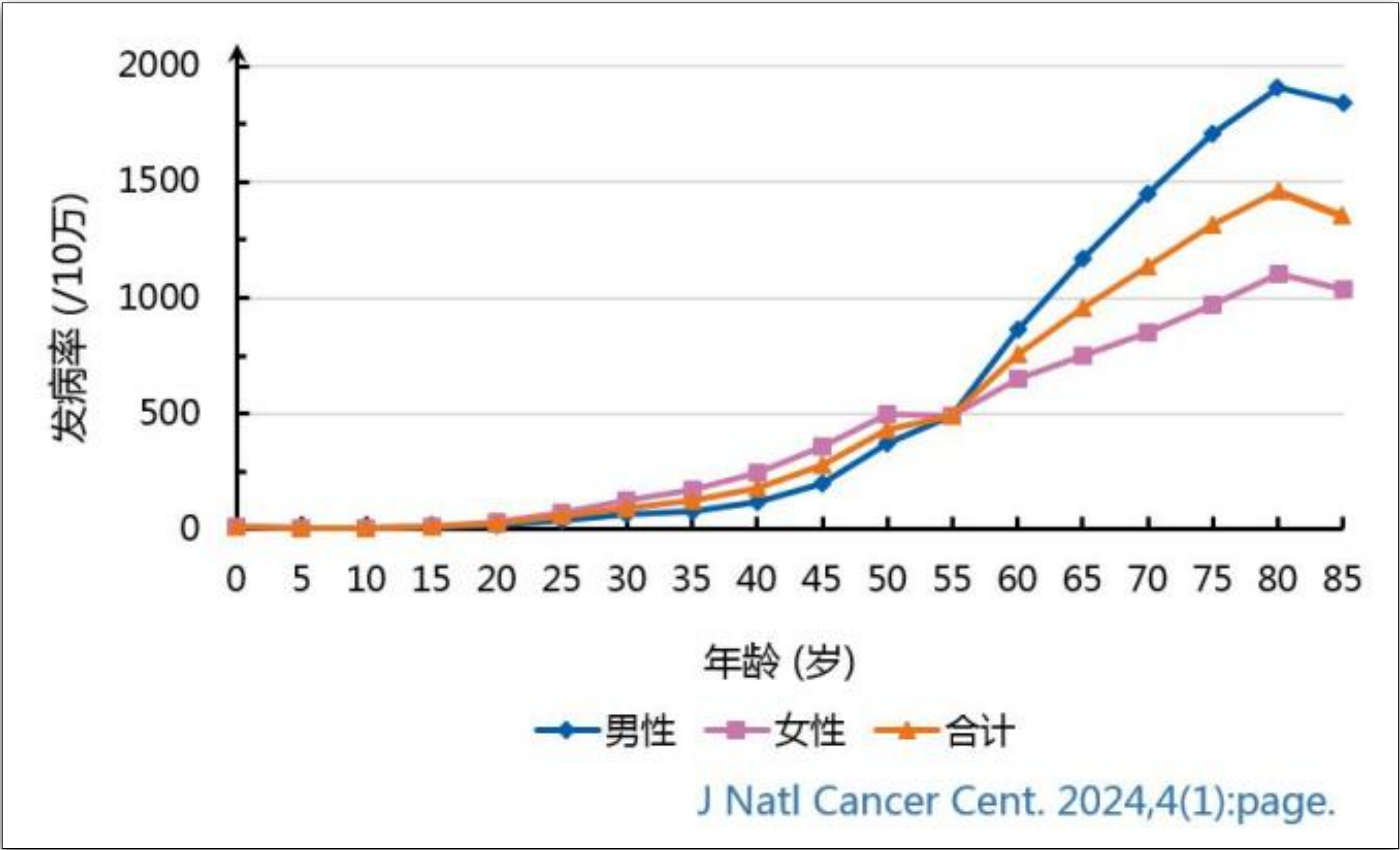
2022年中国全癌种发病人数



2022年中国全癌种死亡人数



2022年中国男女性前十位恶性肿瘤发病率及顺位



中国恶性肿瘤发病率年龄分布

中国2022年估计的恶性肿瘤新发病例和死亡人数与前几年相比有所增加，**发病数的增长一是归因于人口老龄化**，二是随着公众肿瘤预防意识的提升和更便捷的医疗条件，越来越多的居民主动参加肿瘤体检及国家筛查早诊早治项目，**更多的肿瘤病例被及时检出**。死亡数的增长更多是由于人口老龄化导致的。

肺癌是中国恶性肿瘤发病和死亡的首位原因。发病前五位的恶性肿瘤为肺癌、结直肠癌、甲状腺癌、肝癌、胃癌，死亡前五位的恶性肿瘤为肺癌、肝癌、胃癌、结直肠癌、食管癌。

在2000–2018年期间，全癌种标化死亡率平均每年下降1.3%，尤其是食管癌、胃癌和肝癌的年龄标准化发病率和死亡率均呈显著下降趋势，这反映了中国长期坚持上述肿瘤综合防治工作，尤其是自2005年以来逐步推广上消化道肿瘤筛查的初步效果。

○ 降低癌症风险的方式包括

- 不使用烟草；
- 保持健康的体重；
- 健康饮食，包括水果和蔬菜；
- 经常进行身体活动；
- 避免或减少酒精消费；
- 如果属于建议接种疫苗的群体，则请接种人乳头瘤病毒疫苗和乙肝疫苗；
- 避免暴露于紫外线辐射（这主要源于阳光暴晒和人工晒黑设备）和/或采取防晒措施；
- 确保在卫生保健中安全和适当地使用辐射（用于诊断和治疗目的）；
- 尽量减少在职业中接触电离辐射；
- 减少接触室外和室内空气污染，包括氡（一种由铀的自然衰变产生的放射性气体，可能在建筑物中，住宅、学校和工作场所积累）。

应对癌症的关键是：积极筛查，把癌细胞消灭于萌芽。



洞察：

美国癌症协会报告，超重是癌症比例和死亡的主要风险因素，仅次于吸烟。在《超越百岁》一书中，彼得·阿提亚博士表示：肥胖，尤其是内脏脂肪堆积时（代谢综合征指标之一，腹型肥胖），会分泌一系列炎症细胞因子，慢性炎症会创造诱发细胞癌变的环境。因此，控制体重和代谢健康是重点。在四大慢性病中，癌症是最难预防的。除了积极筛查，也可以主动避免风险因素：吸烟、肥胖、胰岛素抵抗。

（四）神经退行性疾病

神经退行性疾病是一类进行性发展的神经系统疾病，是慢性病当中最难治疗的一种。根据《中国阿尔茨海默病报告2024》，2021年中国现存的阿尔茨海默病及其他痴呆患病人数超过1699万例，患病率、死亡率略高于全球平均水平，且随着年龄增加不断上升。不过，近年来社会对阿尔茨海默症的认知率有了大幅提高。

神经退行性疾病主要包括阿尔茨海默病、帕金森病、亨廷顿舞蹈病等。

○ 阿尔茨海默病

阿尔茨海默病，是老年期痴呆最主要的类型，表现为记忆减退、词不达意、思维混乱、判断力下降等脑功能异常和性格行为改变等，严重影响日常生活。年龄越大，患病风险越大。

○ 帕金森病

特征是运动障碍，如震颤、僵硬、运动缓慢等，主要由中脑黑质多巴胺能神经元的退化和Lewy小体的形成导致。

○ 亨廷顿舞蹈病

表现为不自主的舞蹈样动作、认知障碍和精神症状，由亨廷顿基因的突变引起，导致Huntingtin蛋白异常聚集。

○ 肌萎缩侧索硬化症

也称渐冻症，会导致肌肉逐渐无力和萎缩，是由于运动神经元的进行性退变。

根据国际阿尔茨海默病协会发布的《2023 年世界阿尔茨海默病报告》，目前还没有一种全球皆可使用的治愈方法或治疗方法，在这种情况下，**对于阿尔茨海默症来说，预防不仅重要，也是唯一选择。**

《超越百岁》推荐以下措施可以降低阿尔茨海默症风险：

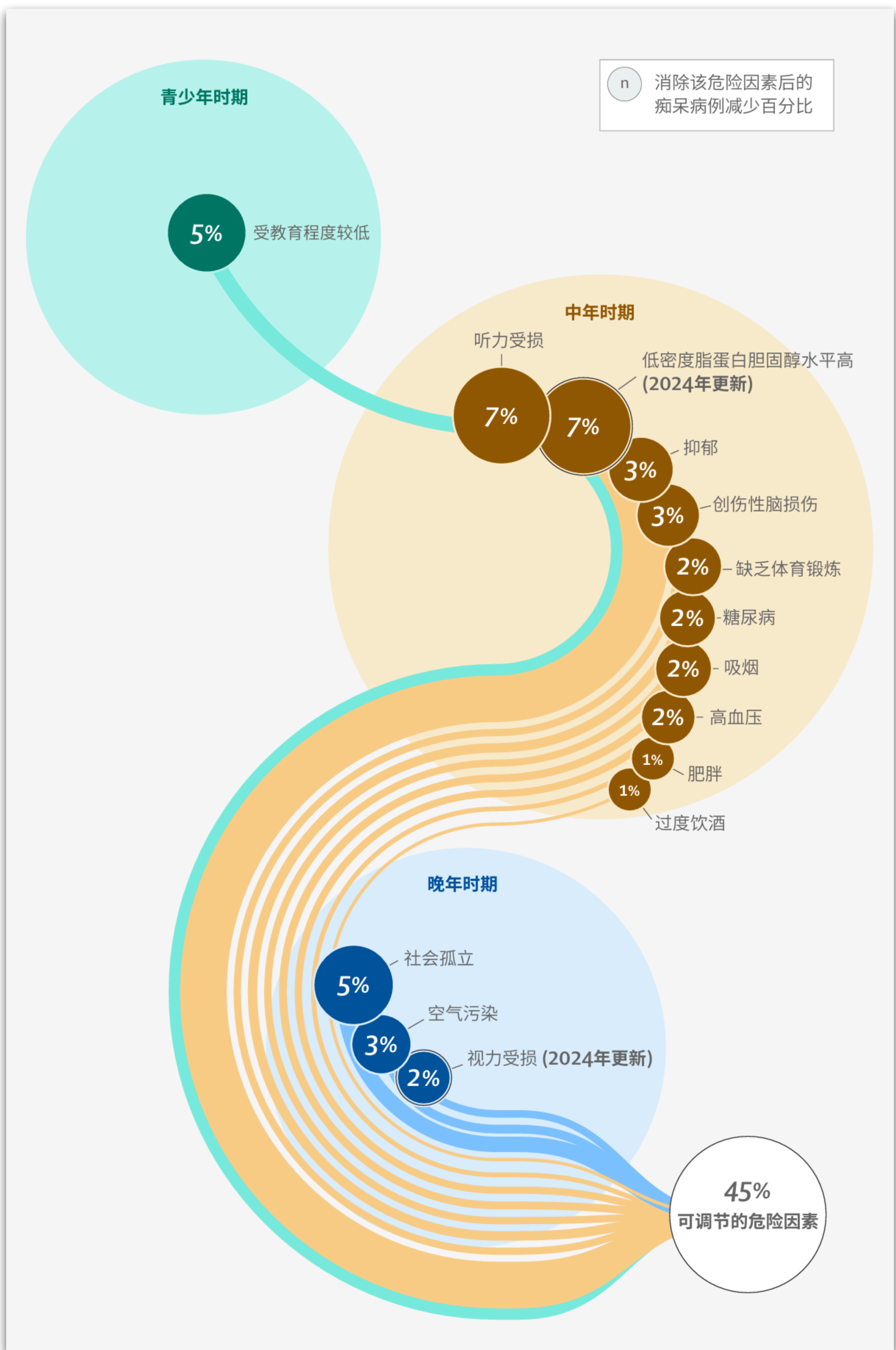
- 控制体重，维持健康的血压、血糖、胆固醇水平；
- 控制饮食、加强运动可以有效预防认识能力下降；
- 学习新事物（比如一门外语或者乐器演奏），“认知储备”可以有效抵抗阿尔茨海默症；
- 保持社交联系，社交活动可以促进大脑健康，减少抑郁和孤立；
- 如果有听力损失，应该矫正听力；
- 减少全身炎症，尤其口腔炎症，应仔细刷牙；
- 不吸烟，减少饮酒，避免过量饮酒；

运动是预防阿尔茨海默症最强大的工具。

洞察

对心脏有益的东西对大脑也有益，维持心血管健康、代谢健康可有效抵抗阿尔茨海默症。在没有治愈方法时，健康饮食、加强运动、维持代谢健康、心血管健康是预防阿尔茨海默症的最好方法。

在预防阿尔茨海默症的工具保中，运动是最强大的工具。



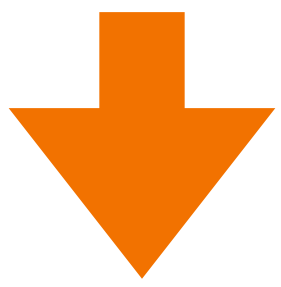
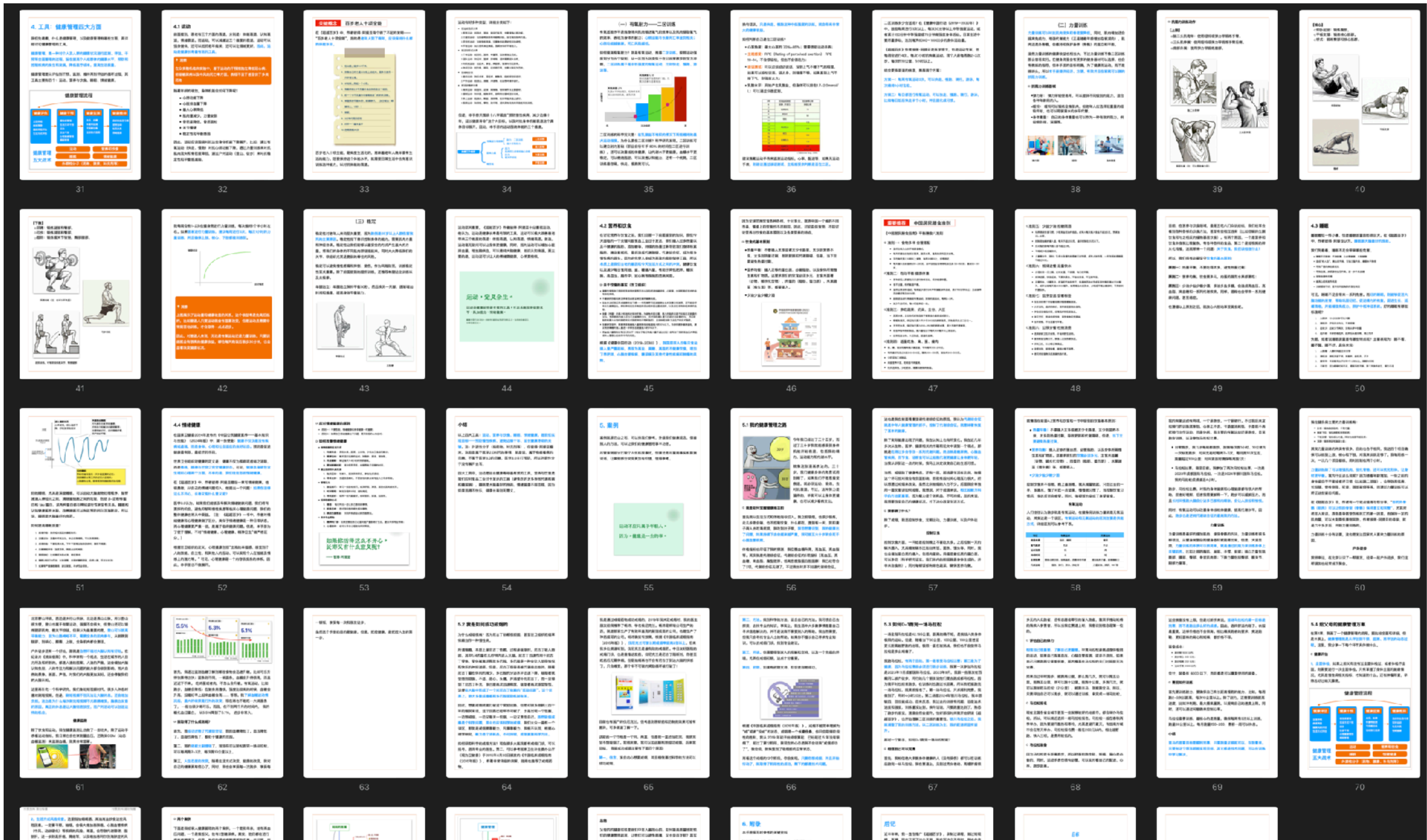
根据《柳叶刀》2024年更新的第三版《痴呆预防、干预和照护重大报告》，通过调节图上这 14 种可改变的相关危险因素，可预防或延迟全球近一半的痴呆病例。

小结

在了解了慢性病“四骑士”后，我们发现都和代谢健康有关，正如《超越百岁》书中强调，糖尿病患者患心血管疾病、癌症、阿兹海默病和其它痴呆症的风险更大，可以说，**糖尿病和相关的代谢功能障碍是所有这些疾病的一个共同点。**

联系衰老的过程，即“分子和细胞层面的受损，身体机能、认知能力、情绪健康的下降，以及慢性病的出现。”，《超越百岁》作者指出：**代谢紊乱，是慢性病四骑士共同的原因。**

试读版结束.....
如果您对后面内容感兴趣， 请为完整版付费
(完整版可参考目录)



付款详情见下页



原价 99，六折抢先阅读，仅需 59！

扫码添加微信
获取完整版！
微信号：shaopinginbj

